



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
DIRETORIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA



INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO CUNHA

PERÍCIA TANATOSCÓPICA Nº 48916 / 2025

REQUISITADO POR: DELEGACIA DE POLICIA DA 190A CIRCUNSCRICAO – PORTO ALEGRE - DP190A CIRC DINTER2/22A DESEC
BIC nº. 123456 / 2025 Data 13 / 04 / 2025
ENCAMINHAR PARA: DELEGACIA DE POLICIA DA 190A CIRCUNSCRICAO – PORTO ALEGRE - DP190A CIRC DINTER2/22A DESEC

O médico legista abaixo assinado, cumprindo determinação do Diretor do Instituto de Medicina Legal Antônio Persivo Cunha, de acordo com o disposto na legislação vigente, examinando às **11:00** horas do dia **13 de Abril de 2025**, na seção de Exames Tanatoscópicos, procedeu a necropsopia de **CARLOS ALBERTO DA SILVA** filho(a) de **NÃO DECLARADO** e de **MARIA DAS DORES DA SILVA**, de cor **Parda**, sexo **Masculino**, cabelo **NÃO INFORMADO**, estado civil **Solteiro (a)**, aparentando a idade de **36 Anos**, peso **NÃO INFORMADO**, de estatura **NÃO INFORMADO**, natural de **PORTO ALEGRE - PE**, nacionalidade **BRASIL**, documento apresentado **RG: 5131681**, profissão **COMERCIANTE**, vestes **NÃO INFORMADO**, sinais particulares **NÃO INFORMADO**, local de ocorrência **NÃO INFORMADO**, verificou o que, a seguir, descreve, pelo que responde a estes quesitos:

HISTÓRICO:

HISTÓRICO: O corpo deu entrada no IML de Caruaru às 09:48 horas do dia 13 de abril de 2025, acompanhado pelo BIC 0140182, assinado pelo delegado de polícia Jefferson Tenório da delegacia de Porto Alegre-PE, que encaminha e identifica o corpo como pertencente a CARLOS ALBERTO DA SILVA, vítima de homicídio doloso por arma branca, no dia 13/04/2025, no Bairro Zona Rural, Porto Alegre-PE.

DESCRIÇÃO

Exame Físico:

Cadáver do sexo masculino, em resfriamento cutâneo, midríase paralítica, rigidez cadavérica, hipóstases dorsais e ausência de sinais vitais. O cadáver apresentava as seguintes lesões: a) Ferimento perfurocortante em região dorsal esquerda (costas), com 3,5 cm de extensão, bordas regulares e profundidade estimada em 6 cm, compatível com instrumento perfurocortante de pequeno porte. b) Ferimento perfurocortante em região abdominal inferior direita, com 2,0 cm de extensão e profundidade estimada em 4 cm, atingindo planos musculares e tecidos adjacentes. c) Ferimento perfurocortante superficial em região torácica posterior esquerda, com 2,0 cm de extensão e 2 cm de profundidade. d) Ferimento perfurocortante superficial em região hipocôndrio esquerdo, medindo 1,5 cm de extensão e 1,5 cm de profundidade. e) Ferimentos perfurocortantes superficiais múltiplos em antebraço direito (total de quatro), variando entre 1,0 e 1,5 cm de extensão, todos de pouca profundidade, compatíveis com lesões de defesa. f) Ferimentos perfurocortantes superficiais em mão esquerda (dois), medindo cerca de 1,0 cm cada, também característicos de reação defensiva. g) Pequenas escoriações na região frontal e em joelho direito, compatíveis com queda após o colapso circulatório. Exame interno: cabeça: após incisão mentopubiana com retirada do plastrão condro-esternal, constatamos: couro cabeludo, abóbada craniana e encéfalo sem alterações de interesse médico legais. Tórax e abdome: após incisão mentopubiana com retirada do plastrão condro-esternal, constatamos: O ferimento dorsal profundo atingiu musculatura paravertebral e perfurou a pleura parietal, ocasionando hemotórax moderado, sem evidências de perfuração pulmonar. O ferimento abdominal perfurou a alça intestinal e provocou hemorragia interna, com presença de sangue livre na cavidade abdominal. As demais lesões foram superficiais, atingindo apenas tecido subcutâneo e fibras musculares. Observou-se baixo poder de corte compatível com instrumento de pequeno porte e lâmina estreita. Exames complementares revelaram anemia falciforme em estágio avançado, que reduziu a capacidade de coagulação e resistência orgânica da vítima, agravando as consequências hemorrágicas. Coração e demais órgãos sem lesões de interesse médico-legal. Foi realizada documentação fotográfica e dactiloscópica.

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO:

A morte foi causada por choque hipovolêmico decorrente de hemorragia interna, secundária a ferimentos perfurocortantes múltiplos, especialmente o abdominal e o dorsal profundo.

As múltiplas lesões superficiais nos antebraços e mãos evidenciam tentativa de defesa da vítima durante o ataque. Ressalte-se que os ferimentos, isoladamente, não seriam suficientes para provocar a morte imediata em pessoa saudável, dada a limitação lesiva do instrumento utilizado.

Contudo, em razão da doença preexistente (anemia falciforme), que aumenta a fragilidade circulatória e agrava hemorragias, as lesões assumiram caráter letal, culminando no óbito após evolução rápida de choque hipovolêmico.

Importante destacar que, embora tenha havido lesão pleural e hemotórax moderado, não foram encontradas perfurações pulmonares.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
DIRETORIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO CUNHA



QUESITOS:

1º) Qual a causa da morte?

Choque hipovolêmico por ferimentos perfurocortantes múltiplos, com complicação pela condição preexistente de anemia falciforme, sem lesão pulmonar.

2º) Qual o instrumento ou meio que produziu a morte?

Instrumento perfurocortante.

3º) Foi ocasionada pelo emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum?

Sem Elementos.

Lido e achado correto o(a) médico(a) legista que assina Dr^(a). ELIAS VALÉRIO DE ALMEIDA - CRM 14253.

Perito responsável



Assinado digitalmente por **ELIAS VALÉRIO DE ALMEIDA**, Médico Legista, Matrícula nº 317.159-1, CPF: xxx.158.327-xx, em 13/04/2025 09:30:46.

Polícia Científica
SDS-PE

Autenticidade, integridade e irretratabilidade deste arquivo eletrônico podem ser conferidas em: <http://validador.sds.pe.gov.br/>